GRATIS-LERNHILFE · WUNDMANAGEMENT

Wunddoku-Spickzettel

Wunden sicher beschreiben, messen und dokumentieren – nach dem DNQP-Expertenstandard chronische Wunden und dem TIME-Prinzip.

Bestehen ist planbar.

Assessment · Messen · Wundgrund · Exsudat · Wundrand · TIME

12	1	A4
Doku-Kriterien	Musterformulierung	druckfertig

INHALT

1. Was in jede Wunddoku gehört
2. Richtig messen
3. Wundgrund beurteilen
4. Exsudat, Rand & Umgebung
5. TIME-Prinzip & Infektzeichen
6. Musterformulierung & No-Gos

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Prüfung. Wundversorgung, Debridement und Materialwahl nach ärztlicher Anordnung, Hausstandard und ggf. Wundexpertin/-experte.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

Wunden sicher dokumentieren

Beschreiben statt bewerten: Wer deine Doku liest, muss die Wunde vor Augen haben – ohne sie zu sehen.

1 WAS IN JEDE WUNDDOKU GEHÖRT

Wundart & Ursache	z. B. Dekubitus Kat. 3, Ulcus cruris venosum, diabetisches Fußsyndrom, OP-Wunde
Lokalisation	Genaue Körperstelle, Seite (rechts/links), ggf. Körperskizze
Wunddauer & Rezidive	Seit wann besteht die Wunde? Gab es sie schon einmal?
Größe	Länge × Breite × Tiefe in cm, dazu Taschen/Unterminierungen
Wundgrund	Gewebearten in Prozent (z. B. 70 % Granulation, 30 % Fibrin)
Exsudat	Menge, Farbe, Konsistenz
Geruch	kein / leicht / stark – nach dem Reinigen beurteilen
Wundrand	z. B. mazeriert, unterminiert, wulstig, gerötet
Wundumgebung	Haut um die Wunde: Rötung, Ödem, Ekzem, Trockenheit
Infektionszeichen	Rötung, Überwärmung, Schwellung, Schmerz, Geruch, Fieber
Schmerz	z. B. NRS 0–10, in Ruhe und beim Verbandwechsel
Versorgung	Material, Wechselintervall, Hautschutz – Datum und Handzeichen

Wundfoto: nur mit Einwilligung, immer mit Maßstab und Datum, möglichst gleiche Position und gleiches Licht – so werden Verläufe vergleichbar.

Richtig messen

Immer gleich messen, sonst sind Verläufe wertlos.

2 MESSEN NACH DEM UHRZEIGERPRINZIP

Orientierung	Kopf der Person = 12 Uhr, Füße = 6 Uhr
Länge	Größte Ausdehnung in Kopf-Fuß-Richtung (12 → 6 Uhr)
Breite	Größte Ausdehnung rechtwinklig dazu (3 → 9 Uhr)
Tiefe	Mit sterilem Watteträger an der tiefsten Stelle, Länge am Träger ablesen
Taschen	Richtung als Uhrzeit + Tiefe in cm angeben, z. B. „Tasche bei 2 Uhr, 1,5 cm“
Hilfsmittel	Einmal-Papierlineal oder Messfolie – nie wiederverwenden

3 WUNDGRUND BEURTEILEN

Schwarz	Nekrose – abgestorbenes Gewebe, Debridement nach ärztlicher Anordnung
Gelb	Fibrinbeläge – müssen gelöst werden, damit Granulation entsteht
Rot	Granulation – gesundes, körniges Gewebe, schützen und feucht halten
Rosa	Epithelisierung – Wunde schließt sich vom Rand her
Grünlich	Verdacht auf Infektion (z. B. Pseudomonas) – melden, Abstrich nach Anordnung

Exsudat, Rand & Umgebung

Exsudat	So sieht es aus	Was es bedeuten kann
Serös	klar, wässrig, hellgelb	normale Wundheilung
Serös-blutig	rosa, dünnflüssig	häufig bei frischen Wunden
Blutig	rot	Gefäßverletzung, z. B. beim Verbandwechsel
Eitrig	trüb, gelb-grün, oft riechend	Hinweis auf Infektion – melden

Menge immer mit angeben: kein · wenig · mäßig · viel (z. B. „Sekundärverband durchfeuchtet“).

4 WUNDRAND & WUNDUMGEBUNG

Mazeriert	weißlich, aufgeweicht – zu viel Feuchtigkeit, Hautschutz und saugfähiger Verband
Unterminiert	Wundrand ist unterhöhlt – Taschen messen und dokumentieren
Wulstig / eingerollt	Rand wächst nicht weiter – Hinweis auf stagnierende Heilung
Gerötet / überwärmt	möglicher Infekt – beobachten, melden
Trocken / schuppig	Hautpflege der Umgebung nach Standard

TIME-Prinzip

International gebräuchliches Schema, um das Wundbett zu beurteilen und gezielt zu behandeln.

T Tissue – Gewebe
Ist nicht vitales Gewebe vorhanden (Nekrose, Fibrin)? Debridement nach Anordnung.

I Infection / Inflammation
Gibt es Zeichen einer Infektion oder Entzündung? Erkennen, melden, behandeln.

M Moisture – Feuchtigkeit
Ist das Wundmilieu zu trocken oder zu nass? Feuchtigkeitsbalance herstellen.

E Edge – Wundrand
Wächst der Rand vor? Rand und Umgebung schützen, Stagnation erkennen.

5 INFEKTIONSZEICHEN – SOFORT MELDEN

- Rötung, Überwärmung, Schwellung und zunehmender Schmerz
- Mehr oder eitriges Exsudat, neuer oder stärkerer Geruch
- Wunde vergrößert sich, Granulation wird brüchig oder blutet leicht
- Fieber oder allgemeine Verschlechterung – an Sepsis denken!

Musterformulierung

„Dekubitus Kategorie 3 sakral, 4,0 × 3,0 × 0,5 cm, Tasche bei 2 Uhr 1,0 cm. Wundgrund 70 % Granulation, 30 % Fibrin. Mäßig seröses Exsudat, kein Geruch nach Reinigung. Wundrand bei 12 Uhr mazeriert, Umgebung reizlos. NRS 2 beim Verbandwechsel. Versorgung nach Wundplan, nächster Wechsel in 3 Tagen." – Datum, Uhrzeit, Handzeichen

No-Gos: „Wunde sieht besser aus" ohne Maße · Bewertungen ohne Beobachtung („infiziert") · Schätzen statt Messen · fehlendes Datum oder Handzeichen · jedes Mal anders messen.

Grundlage: DNQP-Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden"; TIME-Prinzip der Wundbettvorbereitung.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**